

치골결합 누공 (소변-치골 누공)

WARWIKI

환자 안내문 · 소변이 치골로 침투하여 통증과 감염을 일으키는 상태

치골결합 누공(요골반결합 누공이라고도 함)은 요로(방광경부 또는 요도)와 골반 앞쪽의 치골 관절 사이에 생기는 비정상적 통로입니다. 대개 그 뼈에 감염이 동반됩니다. 심한 치골·서혜부 통증과 보행 장애를 유발합니다. 드물지만 심각한 상태이며, 명확한 치료 방법이 있습니다.

이 질환에 대하여

소변이 치골에 지속적으로 닿으면 뼈 감염(골수염)과 관절 손상이 발생합니다. 주요 증상:

- 심한 치골·서혜부·골반 통증, 보행 시 악화
- 보행 곤란 또는 체중 지지 불가
- 반복적 요로감염(UTI); 때로 요누출

초기에는 관절염이나 정형외과 질환으로 오인되어 진단이 늦어지는 경우가 많습니다.

원인

거의 대부분 전립선암 치료의 후기 합병증입니다 — 특히 방사선치료 후, 방광경부나 요도에 추가 시술을 받은 경우에 많습니다. 방사선을 받은 조직은 잘 아물지 않아 소변이 뼈 속으로 침투할 수 있습니다.

용어 설명

치골결합

골반 앞쪽에서 두 치골이 만나는 관절.

치골결합 누공

요로와 그 관절·뼈 사이의 비정상적 통로.

골수염

뼈의 감염.

MRI

뼈와 누공을 가장 잘 보여주는 영상 검사.

변연절제술(Debridement)

감염된 뼈와 조직을 수술로 제거하는 과정.

요로전환

손상 부위를 우회해 소변 경로를 바꾸는 방법으로, 근본적 해결책인 경우가 많습니다.

왜 이렇게 적극적으로 치료하나요? 이 질환의 핵심은 **감염되고 잘 낫지 않는(대개 방사선 손상을 입은) 뼈와 조직**입니다. 단순히 봉합하는 방법은 거의 효과가 없습니다. 지속적인 호전을 위해서는 감염된 뼈를 제거하고 **소변이 해당 부위를 우회하도록** 경로를 바꾸는 수술이 필요합니다. 수술이 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 오랜 고통을 마침내 해소할 수 있는 방법입니다.

진단 방법

- 골반 **MRI**(뼈 확인에 최적)와 요도·방광 내시경 검사
- 감염균 확인을 위한 배양 검사
- 전립선암 치료, 방사선치료, 시술 이력 확인

치료 방법

- 1 **항생제로 골수염 치료.**
- 2 **감염된 뼈 제거 수술**(변연절제술) 및 부위 세척.
- 3 **요로전환** — 방사선 손상 조직은 자연 회복이 어려우므로 많은 경우 **요로전환술**(때로는 손상된 방광·요도 제거 포함)이 필요합니다.
- 4 **조직 피판** — 건강한 근육이나 대망을 이식하여 빈 공간을 채우고 치유를 돕습니다.

치료는 보통 비뇨의학과·정형외과·성형외과가 함께하는 **다학제 협진**으로 진행됩니다.

알아두세요

- 전립선 방사선치료 후 원인 불명의 치골 통증이 있다면, 이 질환 가능성을 의료진에게 꼭 말씀하세요 — 놓치기 쉬운 진단입니다.
- 요로전환이 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 통증과 감염을 **근본적으로 해소**하는 방법인 경우가 많습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 오한, 심한 전신 불편감(감염 확산 가능)
- 치골·서혜부 통증 악화 또는 **보행 불능**
- 소변을 볼 수 없거나 심한 출혈

기억할 세 가지

1. 치골결합 누공은 소변이 치골을 침식하여 심한 통증과 골수염을 일으킵니다 — 대개 전립선 방사선치료 수년 후에 발생합니다.
2. 관절염으로 오인되기 쉬우나 MRI로 진단합니다. 방사선치료 이력을 의료진에게 알려주세요.
3. 치료는 감염 뼈 제거와 요로전환으로 이루어집니다 — 적극적인 치료이지만, 오랜 고통을 마침내 해소할 수 있습니다.